

Oversikt: Hjelpemidler og tjenester, v/kjønnsinkongruens

1. Penisprotese (erigerbar)

Beskrivelse og bestillingsrutine

Seksualteknisk hjelpemiddel (NAV)



2. Brystproteser og BH

Beskrivelse og bestillingsrutine (NAV)



3. Parykker

Beskrivelse og bestillingsrutine (NAV)



4. Binder

Penisproteser (ikke erigerbar)

Dilatorsett

Vulvaprotese

Beskrivelse og bestillingsrutine: *Kan bestilles av lege og psykologspesialist i RSKI og Psykisk helsevern barn og voksne.*



5. Logoped



6. Psykomotorisk fysioterapi



7. Hårreduserende behandling



8. Fertilitetsbehandling



9. Fjerning menstruasjonsblødning



Gyldig fra / til: 04.12.2025 / 04.12.2028

EK-ansvarlig: Monica Blanco

Kongsvik, Runa

Dok.id: D81047

Ref.nr: 5.3.15-12

Versjon: 0.00

Godkjenner: Anne-Jorunn Langeland

Penisprotese, fyllbar

Seksualtekniske hjelpemidler (NAV):

Tilbake til oversikt

- For personer med kjønnsinkongruens, transgutter/menn, kan følgende bestilles av lege i spesialist – eller primærhelsetjeneste.
 - **Erigert penisprotese, fyllbar.**
 - Denne har flere funksjoner: seksuell aktivitet, «packing» og urinering stående.
 - 12 cm eller 15 cm?
 - Farge: Lys beige/beige, sandbeige, lys brun, brun, mørkebrun?
 - Ønskes sele?
- Fyll ut skjema til NAV: [Seksualteknisk hjelpemiddel | www.nav.no](https://www.nav.no/Seksualteknisk_hjelpemiddel)
 - Det er lege som fyller ut skjema, andre kan gjøre dette på vegne av, men lege må skrive under.
 - Produktene som er med i gjeldende avtale vises i bestillingsskjemaet, og det er kun disse som dekkes
 - Pasienten må skrive under søknaden.
 - Skjemaet skal sendes til leverandør
 - Produktene vises på leverandør Quintet sine nettsider.
 - Alle leger i Norge kan bestille seksualtekniske hjelpemidler og det kan kun bestilles ett hjelpemiddel per skjema.

The screenshot shows a web form for ordering a penis prosthesis. It is divided into several sections with radio buttons for selection. The first section, 'Pasienten har behov for følgende hjelpemiddelkategori', lists various categories, with 'Penisprotese' selected. The second section, 'Ønsket lengde på protesen', offers 12 cm and 15 cm, with 15 cm selected. The third section, 'Ønsket farge på protesen', lists five color options: Lys beige/beige, Sandbeige, Lys brun, Brun, and Mørkebrun, with 'Lys beige/beige' selected. The fourth section, 'Er det behov for sele til penisprotesen?', offers 'Ja' and 'Nei', with 'Ja' selected. The fifth section, 'Hvem skal hjelpemiddelet sendes til?', offers 'Pasient' and 'Lege', with 'Pasient' selected. Navigation buttons include '< Steg 3 av 6' and 'Neste steg ->'. Red warning messages are present: 'Du må fylle ut: Ønsket lengde på protesen', 'Du må fylle ut: Ønsket farge på protesen', and 'Du må fylle ut: Erigert penisprotese, fyllbar'.

Pasienten har behov for følgende hjelpemiddelkategori

☐ Dilatorsett

☐ Vakuumpumpe

☐ Vibrator for menn

☐ Vibrator for kvinner

☐ Vibrator for kvinner og menn, utvendig bruk

☐ Fingervibrator for kvinner

☐ Masturbator med vibrering

☒ Penisprotese

Erigert penisprotese

☐ Erigert penisprotese, fyllbar

▲ Du må fylle ut: Erigert penisprotese, fyllbar

Ønsket lengde på protesen

Ta kontakt med Quintet AS ved behov for veiledning eller spørsmål.

☐ 12 cm

☒ 15 cm

▲ Du må fylle ut: Ønsket lengde på protesen

Ønsket farge på protesen

☒ Lys beige/beige

☐ Sandbeige

☐ Lys brun

☐ Brun

☐ Mørkebrun

▲ Du må fylle ut: Ønsket farge på protesen

Er det behov for sele til penisprotesen?

☒ Ja (hoftemål 66 cm - 127 cm)

☐ Nei

▲ Du må fylle ut: Er det behov for sele til penisprotesen?

Hvem skal hjelpemiddelet sendes til?

☒ Pasient

☐ Lege

< Steg 3 av 6

Neste steg ->

Brystproteser og tilskudd til BH

Tilbake til oversikt

Hvem:

Stønad til brystproteser og en BH kan gis personer med kjønnsinkongruens.

Dokumentasjon:

Utdrag fra forskrift,

[Forskrift om stønad til dekning av utgifter til ortopediske hjelpemidler, brystprotese, ansiktsdefektprotese, øyeprotese og parykk – Lovdata](#),

§ 5 Brystprotese

1. « ...Det kan også ytes stønad til personer med kjønnsinkongruens, når behovet er dokumentert med erklæring fra lege eller annet helsepersonell med nødvendig medisinsk kompetanse. Ved fornyelse av protese ytes det stønad uten at det foreligger legeerklæring fra lege eller annet helsepersonell.»

5. «...Ved den første tilpasningen av brystprotese kan det ytes stønad til en spesialbrystholder opp til sats fastsatt av departementet.»...

Både i primær- og spesialisthelsetjeneste kan dokumentere med erklæring.

Hvordan:

- Pasienten får erklæringen av *primær- og spesialisthelsetjenesten*. (av helsepersonel med nødvendig medisinsk kompetanse)
- Pasienten [søker opp nærmeste forhandler](#).
- Forhandler(eks apotek, bandasjist) må ha oppgjørsavtale med Helfo. (Kreftforeningens oversikt over forhandlere med refusjonsavtale med NAV: [Proteseforhandlere – Brystkreftforeningen](#))
- Pasienten bestiller tilpasningstime.
- Pasienten har med/legger frem bekreftelsen/erklæring som bekrefter behovet for brystprotese, for forhandler.
- Ved første gang tilpasning av brystprotese kan en også få bh. Hvis pasienten ønsker BH, må pasienten legge ut for dette, max sum 875kr (pr juni 2025) som refunderes etter søknad til NAV. Forhandler kan bistå med refusjonssøknad.
- Forhandler søker refusjon fra Helfo. (vi trenger ikke å sende søknad/forhåndsgodkjenning til NAV).
- Reiseutgifter til forhandler: Personen det gjelder kan få dekket reiseutgiftene til nærmeste forhandler. (Kontakt Pasientreiser)

[Brystprotese - nav.no](#)

Parykk

Stønad til parykk er dokumentert i [Forskrift om stønad til dekning av utgifter til ortopediske hjelpemidler, brystprotese, ansiktsdefektprotese, øyeprotease og parykk – Lovdata](#)

§ 8 Parykk: Det kan også ytes stønad til personer med kjønnsinkongruens, når behovet er dokumentert med erklæring fra lege eller annet helsepersonell med nødvendig medisinsk kompetanse, og personen helt eller delvis har mistet håret.

Uten hensyn til bestemmelsene i annet ledd kan et medlem under 30 år få stønad til full dekning av nødvendige utgifter for inntil to individuelt tillagede parykker eller inntil seks syntetiske parykker pr. kalenderår.

Det ytes ikke stønad til vedlikehold og annet stell av parykk.

Det kan i stedet for stønad til parykk ytes stønad til hodeplagg etter samme sats som for ordinære parykker.

Hvordan:

- Helsepersonell skriver en bekreftelse på at pasienten har diagnose kjønnsinkongruens, har delvis eller helt mistet håret og har behov for parykk.
 - Helsepersonell må kunne dokumentere at hårtapet har vart i 2-3 år, eller at hårtapet sannsynligvis vil komme til å vare i minst 2-3 år.
- Når pasienten har fått attesten kan vedkomne kontakte en parykkforhandler for avtale om tid for tilpasning. Pasienten velger selv forhandler.
- Attesten fra lege må gis til forhandler som søker refusjon.

[Parykk - nav.no](#)

Behandlingshjelpemidler

Binder, penisproteser, dilatorsett, vulvaprotese

Tilbake til oversikt

Det er kun spesialisthelsetjenesten som kan bestille hjelpemidler til pasienter som har behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten.

Hjelpemidler som tilbys: (Levrandør: [Quintet](#))

Bindere / Kompresjonsvester

(Binder kommer i utførelsen; kort og lang, i fargene hvit, svart, brun og beige).

Brukes av gutter/menn, transmenn og ikke-binære, med behov eller ønske om å få brystkassen til å se flatere ut/maskulinisere brystpartiet.

Man kan også rekvirere svømme- og treningsbinder. Kort (CB19) eller lang versjon(CB13).

Alle behandlere som bestiller binder har ansvar for at opplæring i bruk av binder gjøres med pasientene før binder bestilles. [Her](#) finnes retningslinjer for bruk og størrelsesskjema. Etter første kjøp bestiller pasienten selv det de trenger via Helse Norge eller via telefon til [Behandlingshjelpemidler](#) i helseforetaket de tilhører.

Penisproteser

Uerigert med testikler. 2 utførelser – med og uten forhud. 4 fargenyanser

Urineringsprotese

Truser til proteser

Sleeve (uten testikler) (Kan brukes etter oppstart hormoner, når klitoris er forstørret)

Dilatorsett til bruk med Neovagina

Bestilles av Rikshospitalet i forbindelse med kirurgi

Vulvaprotese:

Ikke under avtale, Avklar i hver tilfelle med behandlingshjelpemidler for mulighet. Grunn til at ikke på avtale; lite forespørsler og veldig begrenset og lite tilfredsstillende utvalg).

Tuckingtruser: I dialog med sykehusinnkjøp om mulighet for å sette på avtale.

Det er blitt bekreftet av 23.9-2025 at
Bindere / Kompresjonsvester og Penisproteser
kan bestilles av Psykisk helsevern for barn og voksne.

Bestillingsrutine for leger og psykologspesialister ved Psykisk helsevern barn og unge:

- Pasienten må ha fått satt en av diagnosene: Z76.89 eller Z76,80 / Z76,81
- Bestilling gjøres i DIPS i helseregionen hvor pasienten er bosatt. [Behandlingshjelpemidler](#)
- Bestilles i DIPS.
 - 1. Sekundærhenvisning behandlingshjelpemidler og
 - 2. Fyll ut dips skjema behandlingshjelpemidler med størrelse/farge/form). (ikke alle har tilgang til skjema – bestill dette).

Pasienten må få info om bruk og forhåndsregler, samt hjelp til å finne rett størrelse.

Info her: [Binder \(kompresjonsvest\) — Quintet](#)

Kan også kontakte RSKI vest for veiledning. Rski-vest@helse-bergen.no eller 55975199 i telefontid 8-11 torsdager.

Logoped

Tilbake til oversikt

- RSKi ved lege henviser til logoped
 - Når pasienten uttrykker ønske om dette i poliklinisk time.
- Når pasient er usikker på ønsket om logoped, kan pasienten, når bestemmelse er tatt, ta kontakt med fastlege og be om henvisning.
 - RSKi kan, når pasienter ønsker dette, gi pasienten- eller ta kontakt med fastlege med, - liste over aktuelle logopeder.
- For å få logopedbehandling/stemmetrening (femininisering/maskulinisering av stemmen) dekket må det være lege* som henviser til logoped. Det må oppgis diagnosekode for kjønnsinkongruens, relevante undersøkelser og kontaktinfo til pasient.
- Leger kan henvise elektronisk via adresseregisteret og NHN (HER-ID) Pasientene blir kontaktet for oppstart av behandling. Noen logopeder uten HRE-nr og må tilsendes henvisning.
- Grunnskolen har PPT tjeneste med logoped, ungdommen kan henvises til PPT, av den som er i kontakt med pasienten eller selv ta kontakt med PPT for logopedbehandling. Det kan være mulig å få behandling der. Varierende om de har kompetanse på maskulinisering/femininisering av stemme.

Fastleger og leger i spesialisthelsetjenesten kan henvise.

Så lenge pasienten er henvist fra lege og henvisningen inkluder diagnosekode, er behandlingen dekt av HELFO.

(PPT tar ikke betalt for sine tjenester)

Logopeder med kompetanse på stemmetrening for personer med kjønnsinkongruens.

Maskulinisering og femininisering.

Område/region

Navn

Bergen	Aina Moe Klinge
Bergen	Berte Taraldsen
Bergen (nettbasert)	Kristine Vreim
Haugesund	Elin Gamst-Albertsen
Stavanger	Elin Sletten
Stavanger	Steffen T. B. Viste
Stavanger 1 dag pr uke (hjemmehørende Oslo)	Anne-Christin Schølberg
Ullensvang	Hanne N. Opedal
Volda	Aase Reite

Hva er psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi bygger på forståelsen om at kroppen er et integrert fysisk, psykisk og sosialt fenomen. Kroppen forstås som et senter for erfaring, kunnskap og hukommelse, og følelser kan uttrykkes, reguleres og hemmes kroppslig. Både fysiske og emosjonelle belastninger, tidligere sykdommer og vanskelige livssituasjoner kan derfor gi kroppslige utslag.

Behandlingen skiller seg fra mye annen medisinsk behandling ved at den ikke er symptomorientert. Kroppens enkeltdeler står i et gjensidig forhold til hverandre slik at de samlet sett vurderes som en funksjonell og samspillende enhet. Det innebærer at et lokalt problem sees i sammenheng med kroppen som helhet. Endringer ett sted i kroppen forventes å påvirke andre kroppsdelene. Pusten tillegges stor betydning siden følelser, pust og muskulære spenningsmønstre forstås som tett sammenvevd. Psykomotorisk fysioterapi er en omstillende behandling der målet er å oppnå en fleksibel og stabil kropp, uten unødige spenninger som kan virke hemmende på funksjonsnivået.

Ref: [Store norske leksikon](#)

- Pasienter og pårørende kan selv henvende seg til psykomotorisk fysioterapi.
- Alle kommuner skal ha et tilbud om dette og man kan henvende seg til fysioterapiavdelingen i kommunene.
- Private psykomotoriske fysioterapeuter tar imot etter vanlige satser. Noen private psykomotorikere har HELFO avtale.
- Ventetid kan variere.
- Vanlig egenandel for frikort når over 16år (HELFO)

Hårreduserende behandling

Link til: [Felles nasjonale prinsipper for hårreduserende behandling for pasienter med kjønnsinkongruens](#)

Intern rutine:

- *Hvis vi har pasienter i behandling hos oss som får hormoner av privatpraktiserende lege, kan vi, om vår lege anbefaler hårreduserende behandling, sende en henvisning til hudavdelingen.*
 - I henvisning må følgende være med:
 - Hårkvalitet og farge
- Pasienten må ha diagnose kjønnsinkongruens. Z76.80/81/89
 - Gjelder mann til kvinne.
 - Gjelder *ikke* "ikke Binære"
- Det kreves at hormonell behandling er i gang.
 - Hormonell behandling må være startet min 3-4 mnd før oppstart. Det må forekomme en aktiv demping av hormonell påvirkning.
 - Ingen nedre aldersgrense.
- Alle henvisninger skal gå via Hudavdelingene i Helseforetaket. Ingen kan behandles privat og få det dekket av det offentlige.
- Oppfølgingsbehandlinger:
 - Pasienten kan rehenvises ved vedvarende eller senere hårvekst.
 - **Fastlege kan da henvise,** Lege må vise til god effekt av første behandling.
- Før oppstart av behandling:
 - Ikke vokse hår, grunnet påvirkning av hårsekkene. Behandlingen vil da måtte utsettes.
 - Barbering er ok.

Lege i RSKI og fastlege kan vurdere å forskrive [Vaniqa](#) uavhengig av tilbud om hårreduserende behandling i spesialist helsetjenesten.

Vaniqa kan benyttes før laserbehandling og underveis, og utan annen behandling.

Fertilitetsbehandling

Tilbake til oversikt

Fra [Metodebok](#):

Det anbefales at pasienter som skal gjennomgå behandling eller har en tilstand som kan skade fruktbarheten informeres om muligheten for fertilitetsbevarende behandling. Dette gjelder også for prepubertale pasienter og deres foresatte.

Når pasienten starter sitt behandlingsløp hos NBTK, henviser NBTK til fertilitetsbehandling dersom pasienten ønsker denne behandlingen.

Skulle det av grunner være nødvendig for lege ved RSKI vest å henvise til fertilitetsklinikk – henvises pasienten til fertilitetsbehandling i Helseforetaket hvor pasienten bor. (11.9.2025: Avklarer mulighet for henvisning når det IKKE er spesialisthelsetjenesten som har initiert behandling)

Behandling er vederlagsfritt for pasientene.

Helse Førde har ikke fertilitetssenter:

Helse Bergen behandler Helse Førdes pasienter

Helse Stavanger har ikke fertilitetssenter :

Helse Fonna behandler Helse Stavangers pasienter.

Helse Fonna:

Tar ut og fryser ned Sæd.

Fertilitetssenteret Helse Bergen:

Tar ut og fryser ned Sæd

[Fertilitetsbevarande behandling, mann - Helse Bergen HF](#)

Uttak av egg avklares. Info kommer.

Fjerning av mensturajsonsblødning.

Amenoré

Hos transgutter/transmenn kan menstruasjonsstopp være ønskelig som del av kjønnsbekreftende behandling.

- **Førstevalg** er gestagenpreparater (typisk kalt “minipille”), der man kan velge fritt mellom piller, sprøyte eller stav. Hormon- eller kobberspiral kan også vurderes, men erfaringsmessig er dette ofte lite ønsket i denne pasientgruppen. Gestagenpreparater gir hos mange amenoré (fullstendig bortfall av menstruasjon), men statistisk sett gir kombinasjonspreparater bedre blødningskontroll. Enkelte opplever imidlertid mer uregelmessige blødninger eller småblødninger ved bruk av gestagen. Det kan være nyttig å prøve ulike administrasjonsformer (piller, sprøyter, stav eller spiral), ettersom responsen varierer og man kan oppnå amenoré med ett preparat selv om et annet ikke har hatt ønsket effekt.
- **Kombinasjonspreparater** (østrogen + gestagen, ofte referert til som “vanlige p-piller”) kan også brukes. Mange pasienter er skeptiske til østrogen, men det er viktig å informere om at dosen er svært lav og ikke forventes å gi ytterligere feminisering. Bivirkninger som brystømhet kan likevel forekomme og hos noen forsterke kjønnsdysfori. Man må også være oppmerksom på at kombinasjonspreparater gir en noe økt risiko for tromboemboliske hendelser.
- De fleste kombinasjons-p-piller inneholder 20–35 µg etinyløstradiol per tablett, som er en mye lavere total dose enn den som brukes ved feminiserende hormonterapi. Vanlig vedlikeholdsdose for eksempel for EstroGel (østrogen i geleform) er 3mg daglig – dvs. 3000 µg.
- Forventet tid til amenoré er vanligvis 3–6 måneder etter oppstart, men det er store individuelle variasjoner. Testosteronbehandling (som kjønnsbekreftende behandling) gir ofte menstruasjonsstopp, men er ikke sikker prevensjon. Prevensjon bør derfor tilbys til pasienter som har mulighet for graviditet.
- Valg av metode bør tas i samarbeid med pasienten og ta hensyn til preferanser, grad av kjønnsdysfori, bivirkningsprofil og individuelle risikofaktorer. Som hos andre pasienter må man vurdere vanlige kontraindikasjoner, inkludert tromboserisiko, migrene med aura og røyking.
- Vi anbefaler å gi pasienten skriftlig informasjon fra Sex og samfunns metodebok om det valgte preparatet:
<https://emetodebok.no/documents/pasinfoprevensjon/>